QCM de révision

68 questions · Corrigés regroupés à la fin

De la fécondation à la nidation

Q01 **À propos des gamètes et du zygote : (2 bonnes réponses)** — Facile

- ☐ A. L'ovocyte possède normalement 46 chromosomes au moment de la fécondation.
- ☐ B. Le zygote est le gamète produit par le testicule.
- ☐ C. Le spermatozoïde apporte normalement 23 chromosomes.
- ☐ D. Le zygote possède normalement 46 chromosomes.
- ☐ E. La fécondation divise par deux le nombre de chromosomes du zygote.

Q02 **Concernant les gonades et les voies génitales féminines : (2 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. Les ovaires sont des gonades.
- ☐ B. L'utérus est la gonade féminine.
- ☐ C. Les spermatozoïdes gagnent la trompe avant de traverser le col.
- ☐ D. Les spermatozoïdes passent par le col avant d'atteindre la cavité utérine.
- ☐ E. Le cordon ombilical transporte les spermatozoïdes vers l'ovaire.

Q03 **Quelles propositions distinguent fécondation et nidation ? (3 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. La fécondation est l'expulsion du placenta.
- ☐ B. La fécondation forme la cellule-œuf.
- ☐ C. Ces événements sont séparés par des divisions et un déplacement de l'œuf.
- ☐ D. La nidation correspond à une implantation dans l'endomètre.
- ☐ E. La nidation est la libération de l'ovocyte par l'ovaire.

Q04 **Lors du développement précoce : (2 bonnes réponses)** — Facile

- ☐ A. La différenciation participe à la spécialisation fonctionnelle.
- ☐ B. Mitose et nidation désignent le même événement.
- ☐ C. La différenciation signifie uniquement une augmentation de taille du corps.
- ☐ D. Les divisions n'apparaissent qu'après la naissance.
- ☐ E. La mitose contribue à augmenter le nombre de cellules.

Q05 **À propos du blastocyste : (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Il s'implante normalement dans le myomètre comme muqueuse de surface.
- [ ] B. Il correspond à l'ovocyte avant sa rencontre avec un spermatozoïde.
- [ ] C. Il apparaît au moment de la délivrance.
- [ ] D. Il possède déjà une organisation pluricellulaire.
- [ ] E. Son apparition marque l'entrée dans la période fœtale du troisième mois.

Grossesse : datation et développement

Q06 **Dans une datation conventionnelle fondée sur une fécondation deux semaines après le début des dernières règles : (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. L'écart de deux semaines prouve la date exacte d'ovulation de chaque femme.
- [ ] B. L'écart retenu est d'environ deux semaines.
- [ ] C. Les semaines d'aménorrhée partent du premier jour des dernières règles.
- [ ] D. 39 semaines d'aménorrhée correspondent à 41 semaines de grossesse.
- [ ] E. Les semaines de grossesse sont comptées depuis la nidation.

Q07 **Une femme présente un retard de règles et des nausées. Que retenir ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Leur association confirme à elle seule la grossesse.
- [ ] B. La fatigue situe précisément le début de la période fœtale.
- [ ] C. Toute grossesse provoque les mêmes modifications mammaires ressenties.
- [ ] D. Ces manifestations peuvent accompagner une grossesse.
- [ ] E. L'absence de nausées exclut une grossesse.

Q08 **Concernant l'hCG et les tests de grossesse : (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Un résultat urinaire négatif trop précoce doit être interprété avec prudence.
- [ ] B. Tous les tests deviennent positifs au même jour après chaque rapport.
- [ ] C. L'hCG peut être recherchée dans les urines.
- [ ] D. Le trophoblaste participe à la production initiale d'hCG.
- [ ] E. L'hCG est uniquement produite par l'antéhypophyse.

Q09 Moyen

Quelles propositions décrivent les périodes embryonnaire et fœtale ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. La période embryonnaire dure les trois trimestres.
- ☐ B. La mise en place des organes domine la période embryonnaire.
- ☐ C. Un organe formé est nécessairement autonome sur le plan fonctionnel.
- ☐ D. La croissance et la maturation se poursuivent pendant la période fœtale.
- ☐ E. La période fœtale débute seulement après le troisième mois complet du développement.

Q10 Moyen

À propos des trimestres de grossesse : (2 bonnes réponses)

- ☐ A. La maturation fonctionnelle se poursuit au troisième trimestre.
- ☐ B. La fin du premier trimestre signifie que toutes les fonctions sont matures.
- ☐ C. Les trimestres sont un découpage du suivi.
- ☐ D. La présentation tête en bas est obligatoire au troisième trimestre.
- ☐ E. Le deuxième trimestre correspond à l'absence de mouvements fœtaux.

Placenta, cordon et liquide amniotique

Q11 Facile

Quelles associations anatomiques sont exactes ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Le cordon relie le fœtus au placenta.
- ☐ B. Le liquide amniotique entoure le fœtus.
- ☐ C. Le placenta est en lien avec la paroi utérine.
- ☐ D. Le cordon relie le fœtus aux ovaires.
- ☐ E. Le liquide amniotique remplace le placenta pour tous les échanges sanguins.

Q12 Moyen

Concernant les échanges placentaires : (2 bonnes réponses)

- ☐ A. La fonction nutritive débute seulement après les premières tétées.
- ☐ B. Des déchets du métabolisme fœtal passent vers la circulation maternelle.
- ☐ C. Le placenta participe à l'apport d'oxygène au fœtus.
- ☐ D. Tout le sang maternel est directement injecté dans le cœur fœtal.
- ☐ E. Le dioxyde de carbone constitue le principal apport respiratoire au fœtus.

Q13 Moyen

Parmi les fonctions du placenta : (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Il participe à la protection immunitaire.
- ☐ B. Il assure la ventilation aérienne des poumons fœtaux.
- ☐ C. Sa fonction endocrine consiste à former les premières selles.
- ☐ D. Sa fonction immunitaire exclut tout passage d'agent infectieux.
- ☐ E. Il possède une fonction endocrine.

Q14 **Quelle proposition décrit le relais hormonal du début de grossesse ? (1 bonne réponse)** Moyen

- ☐ A. L'hCG interrompt immédiatement la sécrétion de progestérone.
- ☐ B. Le corps jaune est une structure du cerveau fœtal.
- ☐ C. Le relais placentaire correspond à l'arrêt de toutes les hormones.
- ☐ D. La progestérone est uniquement fabriquée par les testicules pendant la grossesse.
- ☐ E. L'hCG contribue au maintien du corps jaune.

Q15 **À propos de la relaxine, de l'hPL et du liquide amniotique : (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Le volume du liquide amniotique reste exactement identique à tous les termes.
- ☐ B. La relaxine est le contenu liquide de la poche amniotique.
- ☐ C. L'hPL constitue le score d'adaptation respiratoire du nouveau-né.
- ☐ D. La relaxine participe à l'assouplissement de tissus préparant l'accouchement.
- ☐ E. L'hPL est une hormone placentaire.

Adaptations de la gestante et accouchement

Q16 **Concernant les adaptations maternelles à la grossesse : (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Toute gestante présente des vomissements de même intensité.
- ☐ B. La fréquence des mictions diminue obligatoirement.
- ☐ C. Le débit cardiaque et le volume circulant s'adaptent.
- ☐ D. Les adaptations concernent uniquement l'appareil génital.
- ☐ E. Le volume utérin peut modifier les contraintes sur le diaphragme et la vessie.

Q17 **Pendant le travail obstétrical : (3 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Un rétrocontrôle positif amplifie le phénomène engagé.
- ☐ B. Un rétrocontrôle positif signifie une diminution du signal initial.
- ☐ C. Le myomètre est la muqueuse où s'implante le blastocyste.
- ☐ D. Le myomètre assure les contractions utérines.
- ☐ E. L'ocytocine peut renforcer les contractions.

Q18 **Quelles propositions décrivent la succession de l'accouchement par voie basse ? (2 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. La dilatation concerne l'ouverture progressive du col.
- [ ] B. La naissance du bébé achève nécessairement toutes les étapes.
- [ ] C. La délivrance correspond à l'expulsion du placenta.
- [ ] D. La rupture des membranes précède obligatoirement toute contraction.
- [ ] E. L'expulsion du bébé est appelée nidation.

Q19 **Concernant l'épisiotomie et la césarienne : (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Une césarienne consiste uniquement à inciser le col par voie vaginale.
- [ ] B. Une épisiotomie garantit l'absence de déchirure.
- [ ] C. La césarienne nécessite une ouverture abdominale et utérine.
- [ ] D. L'épisiotomie est systématique à chaque accouchement.
- [ ] E. L'épisiotomie concerne le périnée.

Q20 **La péridurale utilisée lors de l'accouchement : (1 bonne réponse)** Facile

- [ ] A. Elle utilise l'espace péridural.
- [ ] B. Son objectif est la fusion des gamètes.
- [ ] C. Elle constitue la dernière phase d'expulsion du placenta.
- [ ] D. Elle est synonyme d'incision du périnée.
- [ ] E. Elle consiste à prélever du liquide cérébrospinal.

Naissance : trois adaptations majeures

Q21 **À propos des premiers jours après la naissance : (2 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. La pédiatrie se limite aux 28 premiers jours.
- [ ] B. Les suites de couches désignent le premier trimestre de grossesse.
- [ ] C. Le terme nouveau-né s'applique à toute l'enfance.
- [ ] D. Le terme nouveau-né se rapporte aux 28 premiers jours.
- [ ] E. Les suites de couches concernent la mère.

Q22 **Comment les échanges gazeux évoluent-ils à la naissance ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Le liquide pulmonaire se résorbe progressivement lors de la transition.
- [ ] B. Les poumons sont déjà ventilés par l'air maternel dans l'utérus.
- [ ] C. Le premier cri suffit à évaluer toute la fonction respiratoire.
- [ ] D. L'oxygénation fœtale dépend de respirations d'air intra-utérines.
- [ ] E. Le placenta assure les échanges gazeux avant la naissance.

Q23 Moyen

Quelles communications appartiennent à la circulation fœtale ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Le foramen ovale relie les deux ventricules.
- ☐ B. Ces communications servent à augmenter la ventilation aérienne intra-utérine.
- ☐ C. Le canal artériel relie l'artère pulmonaire à l'aorte.
- ☐ D. Le canal artériel relie le cordon à l'ovaire.
- ☐ E. Le foramen ovale communique entre les oreillettes.

Q24 Difficile

À propos du canal d'Arantius et de la transition circulatoire : (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Le canal d'Arantius permet à une partie du sang de contourner le foie.
- ☐ B. Le canal artériel doit être coupé chirurgicalement chez chaque enfant.
- ☐ C. Couper le cordon revient à sectionner directement le foramen ovale.
- ☐ D. La ventilation modifie les conditions de circulation après la naissance.
- ☐ E. Les échanges placentaires continuent à assurer l'oxygénation après interruption du cordon.

Q25 Moyen

Concernant l'adaptation thermique du nouveau-né : (3 bonnes réponses)

- ☐ A. L'adaptation thermique est assurée par le seul score d'Apgar.
- ☐ B. La chaleur est produite uniquement par des frissons intenses.
- ☐ C. La thermogenèse peut être sans frisson.
- ☐ D. Le nouveau-né perd facilement de la chaleur.
- ☐ E. Le séchage et le peau-à-peau contribuent à sa protection thermique.

Q26 Moyen

À propos des fonctions du nouveau-né : (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Succion et déglutition sont deux fonctions distinctes à coordonner.
- ☐ B. Le méconium correspond aux premières selles.
- ☐ C. Les repères de fréquence respiratoire suffisent à eux seuls au tri clinique.
- ☐ D. Le méconium est la première sécrétion placentaire d'hCG.
- ☐ E. La fréquence cardiaque néonatale est normalement identique à celle de l'adulte au repos.

Évaluer le nouveau-né et dépister

Q27 Facile

Comment le score d'Apgar est-il construit ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Il comporte cinq paramètres.
- ☐ B. Le tonus musculaire fait partie des paramètres.
- ☐ C. Chaque paramètre est coté de zéro à deux.
- ☐ D. La taille constitue un de ses cinq paramètres.
- ☐ E. Il comporte dix paramètres cotés chacun sur dix.

Q28 Moyen

Concernant l'interprétation de l'Apgar et les réflexes : (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Le réflexe des points cardinaux consiste à mesurer le périmètre crânien.
- ☐ B. Un score rassurant identifie la cause précise de toute maladie.
- ☐ C. L'agrippement correspond à la fermeture de la main après stimulation palmaire.
- ☐ D. L'Apgar accompagne l'évaluation clinique.
- ☐ E. La marche automatique prouve une marche volontaire déjà acquise.

Q29 Moyen

Quel est le principe du dépistage néonatal ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Il vise une identification précoce pour permettre une prise en charge rapide.
- ☐ B. Il est proposé uniquement aux nouveau-nés symptomatiques.
- ☐ C. Le prélèvement sur buvard est généralement réalisé entre 48 et 72 heures de vie.
- ☐ D. Un résultat anormal confirme immédiatement une maladie sans autre examen.
- ☐ E. Un résultat anormal nécessite des investigations complémentaires.

Q30 Moyen

À propos des maladies citées dans le dépistage : (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Le dépistage auditif remplace l'ensemble du dépistage sur buvard.
- ☐ B. Une ancienne liste de six maladies reste nécessairement exhaustive pour tout programme néonatal actuel.
- ☐ C. La phénylcétonurie correspond à une baisse générale de tous les acides aminés.
- ☐ D. Le déficit en MCAD concerne le métabolisme énergétique de certains acides gras.
- ☐ E. La phénylcétonurie peut entraîner une accumulation de phénylalanine.

Q31 Difficile

Un nouveau-né perd du poids dans les premiers jours et régurgite. Comment interpréter ces observations ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Une perte proche de dix pour cent est toujours anodine.
- ☐ B. La régurgitation est une élimination de méconium par la bouche.
- ☐ C. Des régurgitations peuvent être liées à l'immaturité œsogastrique.
- ☐ D. Un poids de naissance différent de 3,3 kg prouve une anomalie.
- ☐ E. L'alimentation et l'hydratation doivent être prises en compte dans l'évaluation du poids.

Enfance : suivre une trajectoire de développement

Q32 — **Quelles dimensions relèvent du développement psychomoteur ? (2 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. Le développement relationnel se déduit uniquement du poids.
- ☐ B. La préhension concerne la saisie et la manipulation des objets.
- ☐ C. Les observations des parents sont sans utilité.
- ☐ D. Le langage et la relation sont des dimensions du développement.
- ☐ E. La motricité se limite au nombre de mots prononcés.

Q33 — **Comment lire une courbe de croissance ? (2 bonnes réponses)** — Difficile

- ☐ A. Un enfant de petit gabarit peut suivre régulièrement sa courbe.
- ☐ B. Le périmètre crânien mesure directement les capacités de langage.
- ☐ C. Une cassure de trajectoire demande une analyse.
- ☐ D. Une seule mesure remplace l'ensemble du suivi.
- ☐ E. Une mesure située dans la moyenne exclut toute anomalie de trajectoire.

Q34 — **Pour un enfant pesant 20 kg et mesurant 1,10 m : (2 bonnes réponses)** — Difficile

- ☐ A. Les seuls seuils de corpulence adulte suffisent à classer cet enfant.
- ☐ B. L'IMC est proche de 16,5 kg/m².
- ☐ C. L'âge et le sexe interviennent dans l'interprétation pédiatrique.
- ☐ D. La formule nécessite le poids divisé par l'âge.
- ☐ E. L'IMC se calcule en divisant 20 par 110 au carré.

Q35 — **À propos des repères d'acquisition et de la propreté : (2 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. Quelques mots à un âge donné suffisent à évaluer toutes les dimensions du développement.
- ☐ B. Les acquisitions surviennent exactement au même âge chez tous.
- ☐ C. Les âges d'acquisition doivent être replacés dans le développement global.
- ☐ D. La propreté repose sur un contrôle progressif des sphincters.
- ☐ E. Dix-huit mois impose une propreté complète à tous les enfants.

Q36 — **Concernant dentition et maturation osseuse : (2 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. La maturation osseuse s'arrête à la naissance.
- ☐ B. La dentition de lait constitue une classification en cinq stades de Tanner.
- ☐ C. Le calendrier d'apparition des dents est identique chez tous.
- ☐ D. La masse osseuse ne croît pas linéairement toute la vie.
- ☐ E. La dentition de lait comporte vingt dents.

Facteurs de croissance et maturation sensorielle

Q37 — **Quels facteurs de croissance sont extrinsèques ? (2 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. La nutrition et les hormones fonctionnent sans interaction.
- ☐ B. Le lieu de résidence suffit à prédire la qualité de croissance d'un enfant.
- ☐ C. Le cadre psychoaffectif fait partie de l'environnement.
- ☐ D. La sécrétion de GH est un facteur exclusivement extrinsèque.
- ☐ E. Les apports énergétiques et protéiques sont des facteurs extrinsèques.

Q38 — **Concernant l'hormone de croissance : (1 bonne réponse)** — Facile

- ☐ A. La GH est sécrétée uniquement par le placenta adulte.
- ☐ B. La GH désigne une communication entre oreillettes.
- ☐ C. La GH est produite par l'antéhypophyse.
- ☐ D. La GH est le nom du liquide amniotique.
- ☐ E. Le rôle de la GH est limité à l'expulsion du placenta.

Q39 — **Quel enchaînement décrit l'axe thyroïdien ? (3 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. La thyroïde produit la GnRH pour commander l'antéhypophyse.
- ☐ B. La TSH stimule la thyroïde.
- ☐ C. La TSH correspond à la première menstruation.
- ☐ D. T3 et T4 sont des hormones thyroïdiennes.
- ☐ E. La TRH est le signal hypothalamique de cet axe.

Q40 — **Que signifie un rétrocontrôle négatif hormonal ? (1 bonne réponse)** — Moyen

- ☐ A. Il amplifie nécessairement le signal initial.
- ☐ B. Il est synonyme d'augmentation du nombre de cellules.
- ☐ C. Il signifie que toutes les concentrations hormonales sont nulles.
- ☐ D. Il désigne une maladie de la thyroïde dans tous les cas.
- ☐ E. Il contribue à limiter l'activation de l'axe.

Q41 — **Les organes et les proportions corporelles : (2 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. Une taille cérébrale déjà importante peut coexister avec une maturation fonctionnelle en cours.
- ☐ B. Tous les organes suivent une courbe de croissance identique.
- ☐ C. La tête conserve la même proportion du corps de la vie fœtale à l'âge adulte.
- ☐ D. Le développement des connexions nerveuses se déduit uniquement du périmètre crânien.
- ☐ E. L'appareil génital se transforme fortement à la puberté.

Q42 **Quelles définitions visuelles sont exactes ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. L'acuité correspond au volume du cerveau.
- [ ] B. La convergence signifie l'augmentation du nombre de dents.
- [ ] C. L'acuité décrit la finesse de perception.
- [ ] D. La convergence coordonne les deux yeux pour une cible proche.
- [ ] E. L'accommodation ajuste la mise au point.

Q43 **Concernant l'examen sensoriel de l'enfant : (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Toutes les capacités visuelles sont matures dès la naissance.
- [ ] B. Des images peuvent être utilisées pour évaluer un enfant qui ne lit pas.
- [ ] C. La chaîne des osselets est déjà très développée à la naissance.
- [ ] D. Toute évaluation visuelle exige la lecture d'un texte.
- [ ] E. Le développement des osselets prouve que le pavillon ne change plus.

Adolescence et activation de la puberté

Q44 **Quelle différence existe entre adolescence et puberté ? (2 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. La puberté concerne la maturation de la fonction reproductive.
- [ ] B. Les âges moyens imposent le même début de puberté à tous.
- [ ] C. L'adolescence inclut des transformations relationnelles.
- [ ] D. Les deux termes désignent exclusivement un âge civil.
- [ ] E. La puberté exclut toute maturation cérébrale concomitante.

Q45 **Comment s'organise l'axe hormonal pubertaire ? (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Les gonades produisent la TSH pour déclencher la puberté.
- [ ] B. Les gonades répondent à la stimulation hormonale.
- [ ] C. La GnRH est uniquement une hormone du cordon ombilical.
- [ ] D. FSH et LH sont produites par l'antéhypophyse.
- [ ] E. La GnRH est produite par l'hypothalamus.

Q46 **Concernant les changements corporels pubertaires : (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. L'augmentation testiculaire participe à la maturation génitale masculine.
- [ ] B. Le développement mammaire est un caractère sexuel secondaire.
- [ ] C. La mue de la voix ne peut jamais concerner les filles.
- [ ] D. Les caractères sexuels secondaires sont les premières selles.
- [ ] E. La poussée de croissance survient nécessairement le même jour chez tous.

Q47 — **À propos de la maturation cérébrale adolescente : (2 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. L'élagage synaptique réorganise les connexions.
- ☐ B. L'élagage synaptique signifie la disparition de tous les neurones.
- ☐ C. Tous les comportements adolescents s'expliquent par une hormone unique.
- ☐ D. La maturation cérébrale est nécessairement terminée avant la puberté.
- ☐ E. La myélinisation contribue à accélérer la transmission nerveuse.

Tanner, ménarche et maturation reproductive

Q48 — **Comment utiliser la classification de Tanner ? (2 bonnes réponses)** — Facile

- ☐ A. Le stade I correspond à un aspect prépubère.
- ☐ B. Le stade V signifie que tous les aspects psychologiques sont adultes.
- ☐ C. L'âge seul permet d'attribuer le stade.
- ☐ D. Tanner est un score respiratoire néonatal.
- ☐ E. Le stade V correspond à une morphologie adulte.

Q49 — **Quelles observations relèvent de Tanner ? (3 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. Le développement testiculaire et pénien est observé chez le garçon.
- ☐ B. Le nombre de dents de lait détermine le stade.
- ☐ C. Le stade est calculé par le poids divisé par la taille au carré.
- ☐ D. Le développement mammaire est observé chez la fille.
- ☐ E. Deux adolescents du même âge peuvent présenter des stades différents.

Q50 — **Concernant ménarche et premiers cycles : (2 bonnes réponses)** — Difficile

- ☐ A. Tous les premiers cycles comportent nécessairement une ovulation.
- ☐ B. Une absence de possibilité de grossesse est garantie pendant neuf mois après la ménarche.
- ☐ C. Un saignement menstruel ne prouve pas à lui seul une ovulation préalable.
- ☐ D. La ménarche est le stade I de Tanner par définition.
- ☐ E. La ménarche est la première menstruation.

Q51 — **À propos de la maturation reproductive : (2 bonnes réponses)** — Moyen

- ☐ A. La production de gamètes et la production hormonale sont strictement le même processus.
- ☐ B. La FSH participe au développement des tubules séminifères.
- ☐ C. Le corps jaune produit de la progestérone après ovulation.
- ☐ D. Une hausse de progestérone ne peut jamais renseigner sur une ovulation.
- ☐ E. La progestérone est uniquement produite avant toute ovulation par le canal artériel.

Adolescence : relations et vulnérabilités

Q52 **À propos de l'autonomie adolescente : (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Des conflits ponctuels peuvent coexister avec un attachement familial.
- [ ] B. Des enquêtes historiques décrivent exactement tous les adolescents actuels.
- [ ] C. Tout désaccord prouve un conflit permanent.
- [ ] D. Les pairs prennent une place croissante dans la vie sociale.
- [ ] E. Les parents cessent nécessairement d'être des interlocuteurs de santé.

Q53 **Concernant les facteurs de vulnérabilité suicidaire présentés : (3 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Un antécédent de tentative constitue un élément à prendre au sérieux.
- [ ] B. Un facteur isolé ne permet pas de prédire à lui seul un passage à l'acte.
- [ ] C. L'absence d'un facteur cité permet d'exclure toute difficulté.
- [ ] D. Le harcèlement et l'isolement peuvent contribuer à la vulnérabilité.
- [ ] E. Une tentative est toujours un décès par suicide.

Q54 **Comment interpréter les données sur la violence adolescente ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Relations familiales, exposition à la violence et environnement social peuvent interagir.
- [ ] B. Une enquête ancienne peut être généralisée sans période ni population.
- [ ] C. Les différences statistiques rendent la violence normale et obligatoire.
- [ ] D. Un facteur social unique explique tous les comportements violents.
- [ ] E. Une fréquence observée dans un groupe prédit chaque comportement individuel.

Âge adulte, ménopause et andropause

Q55 **Comment décrire l'entrée dans l'âge adulte ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. L'autonomie n'est pas atteinte de manière identique au même moment chez tous.
- [ ] B. L'âge adulte peut comporter des transitions affectives et sociales.
- [ ] C. L'entrée dans l'emploi impose un mariage concomitant.
- [ ] D. La parentalité est une condition nécessaire pour devenir adulte.
- [ ] E. L'âge adulte exclut toute modification intellectuelle ou affective.

Q56 **Concernant la ménopause : (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Elle signifie l'absence de toute hormone sexuelle dans l'organisme.
- [ ] B. Elle comporte l'arrêt de l'activité ovarienne cyclique.
- [ ] C. Les manifestations de la transition sont variables.
- [ ] D. Elle survient exactement à cinquante ans chez toutes les femmes.
- [ ] E. Elle correspond à la première menstruation.

Q57 **Que désigne le terme andropause ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. La production de spermatozoïdes peut persister.
- [ ] B. Tous les hommes présentent obligatoirement les mêmes troubles érectiles.
- [ ] C. Elle impose un arrêt brutal de fertilité au même âge chez tous.
- [ ] D. Elle désigne la fin de la période néonatale.
- [ ] E. La diminution de testostérone peut être progressive et variable.

Q58 **À propos de la maladie à l'âge adulte : (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Chronique signifie automatiquement handicap.
- [ ] B. Les maladies surviennent uniquement à l'âge adulte.
- [ ] C. Toute maladie aiguë devient nécessairement chronique.
- [ ] D. Une maladie peut retentir sur la vie sociale et psychique.
- [ ] E. Une maladie chronique peut nécessiter des adaptations durables.

Vieillissement : définitions et contexte

Q59 **Quelles définitions du vieillissement sont exactes ? (3 bonnes réponses)** Facile

- [ ] A. La sénescence concerne le vieillissement naturel des cellules et tissus.
- [ ] B. La gérontologie inclut des dimensions sociales et psychologiques.
- [ ] C. La gérontologie désigne seulement une opération chirurgicale cardiaque.
- [ ] D. La gériatrie est une discipline médicale.
- [ ] E. La vieillesse est en elle-même une maladie.

Q60 **Comment évoluent les réserves fonctionnelles avec l'âge ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Chaque tendance liée à l'âge prouve une maladie.
- [ ] B. Une baisse de réserve peut coexister avec un fonctionnement suffisant au repos.
- [ ] C. Tous les organes ne vieillissent pas au même rythme.
- [ ] D. Une baisse de réserve entraîne toujours une incapacité totale immédiate.
- [ ] E. Deux personnes du même âge ont nécessairement les mêmes capacités.

Q61 **Concernant l'espérance de vie : (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Elle dépend des conditions de mortalité utilisées dans son calcul.
- [ ] B. Elle indique l'âge exact de décès de chaque nouveau-né.
- [ ] C. Des valeurs historiques deviennent automatiquement des chiffres actuels.
- [ ] D. Elle augmente obligatoirement chaque année.
- [ ] E. Elle peut connaître des reculs ponctuels.

Vieillissement : comprendre les grandes fonctions

Q62 **Concernant peau, os et muscles avec l'avancée en âge : (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. La masse osseuse croît sans maximum jusqu'à la mort.
- [ ] B. L'élasticité cutanée augmente obligatoirement toute la vie.
- [ ] C. Une fragilité osseuse signifie qu'une fracture est déjà présente.
- [ ] D. Une perte musculaire peut retentir sur la force et la fonction.
- [ ] E. Une moindre activité sébacée peut participer à la sécheresse cutanée.

Q63 **À propos du vieillissement cardiovasculaire et respiratoire : (2 bonnes réponses)** Difficile

- [ ] A. Une augmentation de masse myocardique ne prouve pas une amélioration de fonction.
- [ ] B. Tous les cœurs vieillissants grossissent nécessairement pour devenir plus puissants.
- [ ] C. Le vieillissement respiratoire améliore obligatoirement la réserve à l'effort.
- [ ] D. L'hématose oxygène le sang et permet l'élimination du dioxyde de carbone.
- [ ] E. L'hématose est la production d'hormones par le corps jaune.

Q64 **Quelles évolutions urinaires sont possibles avec l'âge ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Le contrôle sphinctérien et la sensation de besoin peuvent se modifier.
- [ ] B. La filtration rénale peut diminuer.
- [ ] C. L'incontinence est obligatoire chez toute personne âgée.
- [ ] D. Filtration rénale et continence désignent exactement la même fonction.
- [ ] E. Une modification de prostate ne peut jamais retentir sur le passage urinaire.

Q65 **Concernant digestion et défenses immunitaires : (3 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Une diminution du goût n'a aucun lien possible avec l'envie de manger.
- [ ] B. Des difficultés de mastication peuvent retentir sur l'alimentation.
- [ ] C. Un ralentissement du transit peut favoriser la constipation.
- [ ] D. Une moindre efficacité immunitaire peut accroître la vulnérabilité infectieuse.
- [ ] E. La constipation prouve à elle seule une baisse des lymphocytes.

Q66 **À propos des sens et du sommeil avec l'âge : (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. La presbytie est une perte du réflexe d'agrippement du nouveau-né.
- [ ] B. La presbytie concerne surtout la vision de près.
- [ ] C. Une baisse auditive peut gêner les échanges relationnels.
- [ ] D. Toute baisse sensorielle affecte obligatoirement tous les sens de façon identique.
- [ ] E. Le sommeil et les rythmes circadiens restent identiques toute la vie.

La mort et la fin du parcours physiologique

Q67 **Quelle proposition respecte la définition biologique de la mort ? (1 bonne réponse)** Moyen

- [ ] A. Tout arrêt momentané d'une fonction est nécessairement irréversible.
- [ ] B. Elle est synonyme de sénescence cellulaire normale.
- [ ] C. Un score d'Apgar suffit à définir juridiquement le décès à tout âge.
- [ ] D. Elle est une cessation complète et définitive de la vie.
- [ ] E. Elle correspond uniquement à une diminution de réserve à l'effort.

Q68 **À propos des grandes fonctions vitales : (2 bonnes réponses)** Moyen

- [ ] A. Chaque organe vital fonctionne indépendamment de toute circulation.
- [ ] B. Une défaillance d'organe vital peut compromettre les autres fonctions.
- [ ] C. Une diminution de force musculaire suffit à établir la cessation définitive de la vie.
- [ ] D. Une seule observation isolée remplace toutes les procédures de constat du décès.
- [ ] E. Les grandes fonctions vitales sont interdépendantes.

Corrigés argumentés

De la fécondation à la nidation

Q01 — Réponses : C, D. Deux gamètes haploïdes de 23 chromosomes fusionnent en un zygote diploïde de 46 chromosomes. A : Faux. Le gamète féminin est haploïde, à 23 chromosomes. B : Faux. Le zygote résulte de la fusion ; le testicule produit des spermatozoïdes. C : Vrai. Le gamète masculin est haploïde. D : Vrai. La fusion réunit les deux jeux chromosomiques. E : Faux. Elle réunit les apports chromosomiques des deux gamètes.

Q02 — Réponses : A, D. Les gonades sont les testicules et les ovaires. Le trajet féminin est : vagin, col, cavité utérine, puis trompe. A : Vrai. Ils appartiennent aux organes reproducteurs producteurs de gamètes. B : Faux. La gonade féminine est l'ovaire. C : Faux. La trompe se situe après le col et la cavité utérine sur ce trajet. D : Vrai. Le trajet suit vagin, col, cavité utérine puis trompe. E : Faux. Le cordon relie le fœtus au placenta pendant la grossesse.

Q03 — Réponses : B, C, D. La fécondation fusionne les gamètes et forme le zygote. La nidation implante le blastocyste dans l'endomètre, muqueuse interne de l'utérus. A : Faux. L'expulsion placentaire est la délivrance. B : Vrai. La fusion des gamètes produit le zygote. C : Vrai. Le développement précoce accompagne le trajet vers l'utérus. D : Vrai. L'endomètre est la muqueuse interne utérine. E : Faux. Cette libération est l'ovulation.

Q04 — Réponses : A, E. Les mitoses augmentent le nombre de cellules. La différenciation leur fait acquérir des caractéristiques et des fonctions spécialisées. A : Vrai. Les cellules acquièrent des caractéristiques propres. B : Faux. La nidation est une implantation ; la mitose est une division cellulaire. C : Faux. La spécialisation ne se confond pas avec la croissance quantitative. D : Faux. Elles ont lieu dès les premiers stades du développement. E : Vrai. Les divisions participent à la multiplication cellulaire.

Q05 — Réponses : D. L'œuf atteint le stade pluricellulaire de blastocyste autour du cinquième jour après fécondation. Il s'implante ensuite dans l'endomètre. A : Faux. L'implantation concerne l'endomètre ; le myomètre est musculaire. B : Faux. Il se forme après la fécondation. C : Faux. La délivrance suit la naissance ; le blastocyste est un stade très précoce. D : Vrai. Le blastocyste résulte des divisions précoces de l'œuf. E : Faux. Le blastocyste se forme dans les premiers jours.

Corrigés argumentés

Grossesse : datation et développement

Q06 — Réponses : B, C. Les semaines de grossesse partent de la fécondation ; les semaines d'aménorrhée du premier jour des dernières règles. Dans cette convention, 39 semaines de grossesse correspondent à environ 41 semaines d'aménorrhée. A : Faux. C'est une convention pédagogique, non une preuve individuelle. B : Vrai. Il dépend du modèle conventionnel de cycle. C : Vrai. C'est le point de départ conventionnel des SA. D : Faux. Le décompte en SA commence plus tôt : la relation est inversée. E : Faux. Elles sont comptées depuis la fécondation.

Q07 — Réponses : D. Retard de règles, nausées, fatigue ou tension mammaire sont des signes possibles et variables. Ils ne confirment pas isolément une grossesse. A : Faux. Les symptômes ne constituent pas une confirmation isolée. B : Faux. Un symptôme ne permet pas cette datation biologique. C : Faux. Les signes et leur intensité ne sont pas identiques chez toutes les femmes. D : Vrai. Elles font partie des signes possibles présentés. E : Faux. Les manifestations varient selon les personnes.

Q08 — Réponses : A, C, D. L'hCG est produite par le trophoblaste puis le placenta. Elle est recherchée dans le sang ou les urines ; un test urinaire trop précoce négatif n'exclut pas à lui seul une grossesse. A : Vrai. Il peut précéder une détection suffisante de l'hormone. B : Faux. La détection dépend du moment et des conditions du test. C : Vrai. Cette recherche est utilisée par les tests urinaires. D : Vrai. Le placenta poursuit ensuite cette production. E : Faux. Sa source retenue ici est trophoblastique puis placentaire.

Q09 — Réponses : B, D. La période embryonnaire met en place les organes. La période fœtale, située à partir du troisième mois, associe croissance et maturation. A : Faux. Elle correspond aux premières semaines du développement. B : Vrai. Cette période est celle des ébauches et de leur organisation. C : Faux. Formation anatomique et maturité fonctionnelle sont distinctes. D : Vrai. Les organes déjà ébauchés continuent d'évoluer. E : Faux. Elle se situe à partir du troisième mois, après environ deux mois.

Q10 — Réponses : A, C. Les trimestres découpent le suivi de grossesse ; embryon et fœtus décrivent des stades biologiques. Croissance et maturation se poursuivent jusqu'à la naissance. A : Vrai. Le développement prépare progressivement à la naissance. B : Faux. Les fonctions continuent à se développer. C : Vrai. Ils ne sont pas trois stades embryologiques distincts. D : Faux. Elle est fréquente, sans être universelle. E : Faux. Les mouvements se développent pendant la grossesse.

Corrigés argumentés

Placenta, cordon et liquide amniotique

Q11 — Réponses : A, B, C. Le placenta est l'interface d'échanges à la paroi utérine ; le cordon relie le fœtus au placenta ; le liquide amniotique entoure et protège le fœtus. A : Vrai. Il constitue leur liaison vasculaire. B : Vrai. Il participe à son environnement et à sa protection. C : Vrai. Son développement accompagne l'implantation. D : Faux. Il le relie au placenta. E : Faux. Les échanges materno-fœtaux reposent sur l'interface placentaire.

Q12 — Réponses : B, C. L'oxygène et les nutriments sont transférés vers le fœtus. Le dioxyde de carbone et des déchets métaboliques passent vers la circulation maternelle, sans mélange direct global des deux sangs. A : Faux. Le placenta apporte déjà des nutriments avant la naissance. B : Vrai. Cela correspond à la fonction excrétrice placentaire. C : Vrai. Les échanges gazeux précèdent la ventilation aérienne. D : Faux. Les circulations restent distinctes et échangent à l'interface. E : Faux. Le fœtus reçoit de l'oxygène et élimine du dioxyde de carbone.

Q13 — Réponses : A, E. Le placenta assure des fonctions nutritive, respiratoire, excrétrice, endocrine et immunitaire. Sa protection ne constitue pas une barrière absolue contre toute infection. A : Vrai. Cette participation ne supprime pas tout risque de transmission infectieuse. B : Faux. Les échanges gazeux sont placentaires ; les poumons ne sont pas ventilés par de l'air. C : Faux. Les premières selles sont le méconium ; endocrine signifie sécrétion hormonale. D : Faux. La barrière placentaire n'est pas absolue. E : Vrai. Il produit des hormones impliquées dans la grossesse.

Q14 — Réponses : E. L'hCG maintient le corps jaune, qui continue à sécréter notamment œstrogènes et progestérone. Le placenta prend progressivement le relais de cette production. A : Faux. Elle soutient le corps jaune et ses sécrétions. B : Faux. C'est une structure ovarienne issue du follicule après ovulation. C : Faux. Le placenta assure ensuite une production hormonale. D : Faux. Le corps jaune puis le placenta sont les sources considérées ici. E : Vrai. Ce soutien intervient au début de la grossesse.

Q15 — Réponses : D, E. La relaxine participe à l'assouplissement des tissus du bassin et du col. L'hormone lactogène placentaire, ou hPL, participe aux adaptations de la grossesse, notamment mammaires. A : Faux. L'ordre de grandeur varie avec le terme. B : Faux. C'est une hormone, distincte du liquide amniotique. C : Faux. Le score d'adaptation évoqué est l'Apgar. D : Vrai. Elle contribue aux modifications du bassin et du col. E : Vrai. Son nom est hormone lactogène placentaire.

Corrigés argumentés

Adaptations de la gestante et accouchement

Q16 — Réponses : C, E. L'organisme maternel répond aux besoins de la grossesse et à l'augmentation du volume utérin : adaptations circulatoires, ventilatoires, digestives, urinaires et mammaires, variables selon les femmes. A : Faux. Les manifestations digestives sont variables. B : Faux. Des mictions plus fréquentes sont possibles. C : Vrai. Les besoins de la grossesse modifient le fonctionnement circulatoire. D : Faux. Plusieurs fonctions maternelles sont concernées. E : Vrai. Cela contribue aux modifications respiratoires et urinaires.

Q17 — Réponses : A, D, E. Le myomètre est le muscle utérin. L'ocytocine renforce ses contractions ; un rétrocontrôle positif peut amplifier les signaux associés au travail. A : Vrai. Il renforce ici les signaux favorisant les contractions. B : Faux. Cette limitation correspond au principe du rétrocontrôle négatif. C : Faux. Cette muqueuse est l'endomètre. D : Vrai. C'est la couche musculaire de la paroi de l'utérus. E : Vrai. Elle participe à la dynamique du travail.

Q18 — Réponses : A, C. Dilatation du col, expulsion de l'enfant, puis délivrance du placenta. Le suivi maternel se poursuit après la naissance du bébé. A : Vrai. Elle accompagne le travail utérin. B : Faux. La délivrance placentaire doit encore se dérouler. C : Vrai. Elle suit la naissance de l'enfant. D : Faux. Son moment n'est pas systématiquement le premier événement. E : Faux. La nidation est l'implantation précoce du blastocyste.

Q19 — Réponses : C, E. L'épisiotomie est une incision du périnée dans certaines situations. La césarienne permet la naissance par ouverture des parois abdominale et utérine. A : Faux. Elle implique les parois abdominale et utérine. B : Faux. Elle ne constitue pas une garantie absolue. C : Vrai. Elle donne accès au fœtus par voie chirurgicale. D : Faux. Elle est réservée à certaines situations obstétricales. E : Vrai. Cette incision ne porte pas sur la paroi utérine.

Q20 — Réponses : A. La péridurale est une analgésie loco-régionale utilisant l'espace péridural. Elle ne correspond pas à un prélèvement de liquide cérébrospinal. A : Vrai. Le nom désigne l'espace concerné par la technique. B : Faux. Il s'agit d'une technique d'analgésie. C : Faux. L'expulsion du placenta est la délivrance. D : Faux. L'incision du périnée est l'épisiotomie. E : Faux. Un prélèvement de ce liquide relève d'un autre geste.

Corrigés argumentés

Naissance : trois adaptations majeures

Q21 — Réponses : D, E. La période néonatale couvre les 28 premiers jours de l'enfant. Les suites de couches désignent la période maternelle après l'accouchement. A : Faux. Elle suit l'enfant jusqu'à l'adolescence. B : Faux. Elles débutent après l'accouchement. C : Faux. Il se limite à la période néonatale. D : Vrai. Il correspond à la période néonatale. E : Vrai. Elles suivent l'accouchement.

Q22 — Réponses : A, E. Avant la naissance, les échanges gazeux ont lieu au placenta. Les premières respirations aèrent les poumons ; le liquide pulmonaire se résorbe et les poumons prennent le relais. A : Vrai. L'air occupe progressivement les espaces pulmonaires. B : Faux. L'oxygène traverse l'interface placentaire, sans ventilation aérienne fœtale. C : Faux. Il illustre la mise en route sans remplacer l'évaluation. D : Faux. Les échanges sont placentaires avant la naissance. E : Vrai. Les poumons fœtaux ne sont pas ventilés par de l'air.

Q23 — Réponses : C, E. Le foramen ovale relie les deux oreillettes. Le canal artériel relie l'artère pulmonaire à l'aorte. Ils permettent à une partie du sang de contourner les poumons non ventilés. A : Faux. Il concerne les oreillettes, non les ventricules. B : Faux. Elles sont adaptées à l'absence de ventilation aérienne fœtale. C : Vrai. Il dérive une partie du débit de la circulation pulmonaire. D : Faux. Il s'agit d'une communication vasculaire thoracique fœtale. E : Vrai. Il s'agit d'une communication interauriculaire fœtale.

Q24 — Réponses : A, D. Le canal d'Arantius est un conduit veineux dérivant une partie du trajet hépatique. Après la naissance, ventilation et interruption des échanges ombilicaux modifient pressions et débits. A : Vrai. Il appartient au trajet veineux fœtal lié au cordon. B : Faux. Sa fermeture s'inscrit normalement dans la transition physiologique. C : Faux. Le cordon est distinct de cette communication intracardiaque. D : Vrai. Les communications fœtales perdent progressivement leur rôle de dérivation. E : Faux. L'oxygénation doit alors être assurée par les poumons.

Q25 — Réponses : C, D, E. Le passage à un milieu plus frais favorise les pertes de chaleur. Séchage, protection thermique et peau-à-peau les limitent ; la production de chaleur mobilise notamment une thermogenèse sans frisson. A : Faux. Un score décrit l'état ; il ne fournit pas une protection thermique. B : Faux. La thermogenèse sans frisson a un rôle important. C : Vrai. Le frisson ne résume pas la production néonatale de chaleur. D : Vrai. Il quitte un milieu intra-utérin proche de 37 degrés. E : Vrai. Ils participent à la prévention du refroidissement.

Corrigés argumentés

Q26 — Réponses : A, B. Le méconium constitue les premières selles. L'alimentation nécessite la coordination de la succion, de la déglutition, de la digestion et de l'élimination. A : Vrai. Saisir et aspirer le lait ne suffit pas à le faire progresser vers l'estomac. B : Vrai. Il est éliminé après la naissance. C : Faux. Ils ne remplacent pas une évaluation de l'enfant et du contexte. D : Faux. Il s'agit de selles, distinctes des hormones. E : Faux. La fréquence est plus élevée chez le nouveau-né que chez l'adulte au repos.

Évaluer le nouveau-né et dépister

Q27 — Réponses : A, B, C. Apparence, pouls, grimace, activité et respiration : cinq paramètres cotés chacun de zéro à deux, pour un total maximal de dix. A : Vrai. Chacun décrit une dimension de l'adaptation du nouveau-né. B : Vrai. Il correspond à l'activité. C : Vrai. La somme peut donc aller de zéro à dix. D : Faux. Les mensurations ne font pas partie de l'Apgar. E : Faux. Le total est sur dix, avec cinq paramètres sur deux.

Q28 — Réponses : C, D. L'Apgar apprécie l'état et l'adaptation du nouveau-né ; il ne pose pas un diagnostic étiologique. L'examen neurologique comporte aussi la recherche de réflexes. A : Faux. Il oriente la tête vers une stimulation proche de la bouche. B : Faux. Le score n'est pas un diagnostic étiologique. C : Vrai. C'est un réflexe recherché lors de l'examen neurologique. D : Vrai. Il apporte une appréciation de l'adaptation. E : Faux. Il s'agit d'un réflexe néonatal, distinct de l'acquisition ultérieure.

Q29 — Réponses : A, C, E. Le dépistage recherche précocement certaines maladies, souvent avant les symptômes. Un résultat anormal conduit à des investigations de confirmation ; il n'est pas à lui seul un diagnostic définitif. A : Vrai. C'est l'objectif du programme. B : Faux. Il est systématiquement proposé à tous les nouveau-nés. C : Vrai. Il s'inscrit dans une information et un accord des parents. D : Faux. Il nécessite une confirmation. E : Vrai. Dépistage et confirmation doivent être distingués.

Q30 — Réponses : D, E. La phénylcétonurie entraîne une accumulation de phénylalanine par défaut de dégradation. Le déficit en MCAD concerne l'utilisation énergétique de certains acides gras. A : Faux. Les deux dépistages sont complémentaires. B : Faux. Les programmes peuvent être élargis : une ancienne liste ne suffit pas à définir leur périmètre actuel. C : Faux. Le problème retenu est l'accumulation de phénylalanine. D : Vrai. Il ne se confond pas avec la phénylcétonurie. E : Vrai. Elle est liée à un défaut de dégradation de cet acide aminé.

Corrigés argumentés

Q31 — Réponses : C, E. L'évolution du poids doit être appréciée avec l'alimentation et l'hydratation. Un pourcentage isolé ne dispense pas d'évaluation ; une régurgitation est une remontée gastrique, distincte de l'élimination des selles. A : Faux. Elle ne doit pas être banalisée sans évaluation. B : Faux. Le méconium est éliminé comme selles ; les phénomènes sont distincts. C : Vrai. Elles correspondent à une remontée du contenu gastrique. D : Faux. Il s'agit d'un ordre de grandeur, non d'une valeur obligatoire. E : Vrai. La perte pondérale ne s'interprète pas par un chiffre seul.

Enfance : suivre une trajectoire de développement

Q32 — Réponses : B, D. Motricité, préhension, relation et langage. Leurs acquisitions s'apprécient ensemble et dans une trajectoire, avec les observations des parents. A : Faux. Les interactions doivent être observées pour elles-mêmes. B : Vrai. Elle évolue vers une précision croissante. C : Faux. Elles apportent des informations sur la vie quotidienne. D : Vrai. Le développement ne se réduit pas aux déplacements. E : Faux. Elle concerne le contrôle postural et les déplacements.

Q33 — Réponses : A, C. Des mesures répétées permettent de suivre la pente. Un petit gabarit suivant sa courbe diffère d'une cassure de trajectoire, qui demande une analyse même si la mesure semble moyenne. A : Vrai. Le petit gabarit ne suffit pas à conclure à une anomalie. B : Faux. Il suit la croissance de la tête dans le contexte neurologique. C : Vrai. Une valeur isolée ne résume pas l'évolution. D : Faux. Le suivi repose sur des mesures répétées. E : Faux. Une rupture peut exister malgré une mesure apparemment moyenne.

Q34 — Réponses : B, C. L'IMC vaut 20 divisé par 1,10 au carré, soit environ 16,5 kilogrammes par mètre carré. Il faut ensuite utiliser une courbe adaptée à l'âge et au sexe. A : Faux. Les courbes pédiatriques sont nécessaires. B : Vrai. Le calcul est 20 divisé par 1,21. C : Vrai. Ils permettent de choisir la courbe adaptée. D : Faux. Le dénominateur est la taille au carré. E : Faux. La taille doit être exprimée en mètres.

Q35 — Réponses : C, D. Ils orientent une lecture globale et progressive. Un âge moyen ne constitue pas à lui seul une limite diagnostique ni une exigence d'acquisition complète pour tous. A : Faux. La motricité, la préhension et la relation doivent aussi être considérées. B : Faux. Il existe une variabilité individuelle. C : Vrai. Ils sont des repères et non une grille isolée. D : Vrai. Les acquisitions urétrale et anale se construisent progressivement. E : Faux. Cet âge est un repère indicatif.

Corrigés argumentés

Q36 — Réponses : D, E. La dentition de lait comporte vingt dents, avec un calendrier variable. La masse osseuse augmente pendant le développement, atteint un maximum puis peut diminuer. A : Faux. Elle se poursuit dans l'enfance et à la puberté. B : Faux. Tanner concerne la maturation sexuelle. C : Faux. Le calendrier varie selon les enfants. D : Vrai. La courbe présente une augmentation, un maximum puis une diminution. E : Vrai. La dentition temporaire complète comprend vingt dents.

Facteurs de croissance et maturation sensorielle

Q37 — Réponses : C, E. Les facteurs extrinsèques relèvent de l'environnement, notamment nutrition et contexte psychoaffectif ou socio-économique. Les facteurs intrinsèques comprennent les régulations biologiques et hormonales. A : Faux. La croissance dépend de leurs interactions avec l'environnement. B : Faux. Les exemples ville-campagne ne permettent pas ce déterminisme. C : Vrai. Il interagit avec les conditions du développement. D : Faux. Elle relève d'une régulation hormonale intrinsèque. E : Vrai. Ils relèvent de l'alimentation.

Q38 — Réponses : C. La GH, hormone de croissance, est produite par l'antéhypophyse sous régulation hypothalamique et participe à la croissance. A : Faux. La source de cet axe est l'antéhypophyse. B : Faux. Cette communication est le foramen ovale. C : Vrai. Celle-ci est le lobe antérieur de l'hypophyse. D : Faux. C'est une hormone, non un liquide de protection. E : Faux. Elle participe à la croissance ; la délivrance relève d'autres mécanismes.

Q39 — Réponses : B, D, E. Hypothalamus : TRH ; antéhypophyse : TSH ; thyroïde : T3 et T4. Les hormones thyroïdiennes participent au métabolisme et aux maturations osseuse et cérébrale. A : Faux. La GnRH est hypothalamique et appartient à l'axe gonadique. B : Vrai. Elle est produite par l'antéhypophyse. C : Faux. La première menstruation est la ménarche. D : Vrai. Elles participent aux maturations et à l'activité métabolique. E : Vrai. Elle intervient en amont de la stimulation hypophysaire.

Q40 — Réponses : E. Le rétrocontrôle négatif limite l'activation de l'axe en retour. Le rétrocontrôle positif renforce le phénomène, comme l'amplification des contractions pendant le travail. A : Faux. Cette amplification caractérise un rétrocontrôle positif. B : Faux. La multiplication cellulaire relève des divisions. C : Faux. Il s'agit d'un mécanisme de régulation, non d'une absence d'hormones. D : Faux. C'est aussi un mécanisme physiologique. E : Vrai. Le signal agit en retour sur sa régulation.

Corrigés argumentés

Q41 — Réponses : A, E. La taille et les fonctions ne mûrissent pas au même rythme. Les organes ont des trajectoires différentes ; les proportions de la tête, du tronc et des membres évoluent aussi. A : Vrai. Le chiffre de taille ne mesure pas l'achèvement des fonctions. B : Faux. Leurs rythmes de développement diffèrent. C : Faux. Les proportions corporelles changent avec la croissance. D : Faux. Cette mesure ne résume pas la maturation fonctionnelle. E : Vrai. Sa trajectoire diffère de celle du cerveau.

Q42 — Réponses : C, D, E. L'acuité est la finesse de perception ; l'accommodation ajuste la mise au point par le cristallin ; la convergence coordonne l'orientation des deux yeux vers une cible proche. A : Faux. C'est une capacité de perception visuelle. B : Faux. Elle relève de la fonction visuelle. C : Vrai. Elle ne se confond pas avec l'orientation oculaire. D : Vrai. Elle concerne leur orientation. E : Vrai. Elle implique le cristallin.

Q43 — Réponses : B, C. Non. Des évaluations adaptées à l'âge peuvent utiliser des images. La vision mûrit progressivement ; une structure anatomique déjà développée ne signifie pas que toutes les fonctions sont achevées. A : Faux. Acuité et coordination se développent progressivement. B : Vrai. L'examen visuel peut être adapté à l'âge. C : Vrai. Cela ne signifie pas que toute l'oreille reste inchangée ensuite. D : Faux. D'autres supports existent. E : Faux. Il faut distinguer chaîne ossiculaire et oreille entière.

Adolescence et activation de la puberté

Q44 — Réponses : A, C. La puberté est la maturation physique donnant accès à la fonction reproductive. L'adolescence est une transition plus large, également intellectuelle, affective et sociale. A : Vrai. Elle comprend des changements hormonaux et corporels. B : Faux. Les intervalles sont indicatifs. C : Vrai. Elle dépasse la seule maturation reproductive. D : Faux. Ils décrivent des processus de transition et de maturation. E : Faux. Plusieurs transformations se déroulent en parallèle.

Q45 — Réponses : B, D, E. La GnRH hypothalamique stimule l'antéhypophyse, qui sécrète FSH et LH ; ces hormones stimulent les gonades et la production d'hormones sexuelles. A : Faux. La TSH relève de l'axe thyroïdien et est hypophysaire. B : Vrai. Leur réponse participe aux changements pubertaires. C : Faux. Elle est hypothalamique. D : Vrai. Elles sont des gonadotrophines. E : Vrai. Elle constitue le signal en amont de cet axe.

Q46 — Réponses : A, B. Maturation des organes génitaux, caractères sexuels secondaires et poussée de croissance. Leur rythme varie ; la poussée est généralement plus précoce chez la fille que chez le garçon. A : Vrai. Elle est un repère de développement pubertaire. B : Vrai. Il apparaît au cours de la maturation pubertaire. C : Faux. La voix peut aussi se modifier chez elles, souvent moins nettement. D : Faux. Les premières selles sont le méconium. E : Faux. Les âges et rythmes sont variables.

Corrigés argumentés

Q47 — Réponses : A, E. La myélinisation facilite la transmission rapide des messages nerveux. L'élagage synaptique sélectionne et réorganise des connexions. Ces changements interagissent avec les expériences et le contexte. A : Vrai. Il ne correspond pas à l'arrêt de toute activité cérébrale. B : Faux. Il concerne la sélection de connexions. C : Faux. Les changements biologiques, les expériences et les relations interagissent. D : Faux. Elle se poursuit pendant cette période. E : Vrai. La myéline participe à l'efficacité de conduction.

Tanner, ménarche et maturation reproductive

Q48 — Réponses : A, E. Tanner décrit la maturation sexuelle observée : stade I prépubère, stade V de morphologie adulte. Le classement repose sur les caractères physiques, pas sur l'âge seul. A : Vrai. C'est l'extrémité initiale de la classification. B : Faux. La classification décrit la maturation sexuelle morphologique. C : Faux. Les caractères morphologiques doivent être observés. D : Faux. Le score néonatal évoqué est l'Apgar. E : Vrai. Il constitue l'extrémité finale.

Q49 — Réponses : A, D, E. Chez la fille : développement mammaire et pilosité pubienne. Chez le garçon : développement génital et pilosité pubienne. Deux adolescents du même âge peuvent avoir des stades différents. A : Vrai. Ces caractères décrivent la maturation génitale. B : Faux. La dentition n'est pas le critère de cette classification. C : Faux. Cette formule calcule l'IMC. D : Vrai. Il fait partie des caractères de maturation sexuelle. E : Vrai. L'âge ne résume pas la progression morphologique.

Q50 — Réponses : C, E. La ménarche est la première menstruation. Les premiers cycles peuvent être anovulatoires, mais aucune période obligatoire sans ovulation ne peut être garantie. A : Faux. Leur fonctionnement peut être encore irrégulier. B : Faux. Le délai cité ne constitue pas une garantie individuelle. C : Vrai. Les premiers cycles peuvent être anovulatoires. D : Faux. Tanner I est prépubère ; les notions ne se confondent pas. E : Vrai. Elle ne désigne pas la fin de l'activité ovarienne.

Q51 — Réponses : B, C. Après l'ovulation, le follicule donne le corps jaune, qui sécrète notamment de la progestérone. Chez le garçon, la FSH participe au développement des tubules séminifères. A : Faux. Ces fonctions gonadiques sont liées mais distinctes. B : Vrai. Ces structures sont liées à la production de spermatozoïdes. C : Vrai. Cette sécrétion appartient à la phase suivant l'ovulation. D : Faux. Au moment approprié, elle peut en témoigner. E : Faux. Le corps jaune ovarien est la structure concernée ici.

Corrigés argumentés

Adolescence : relations et vulnérabilités

Q52 — Réponses : A, D. Non. Les pairs prennent une place croissante, tandis que les parents peuvent rester des interlocuteurs importants. Attachement et désaccords ponctuels peuvent coexister. A : Vrai. L'autonomie ne signifie pas une rupture systématique. B : Faux. Leur période et leur population ne permettent pas cette généralisation. C : Faux. Les difficultés peuvent être momentanées. D : Vrai. Les relations se diversifient pendant l'adolescence. E : Faux. Ils peuvent conserver une place importante.

Q53 — Réponses : A, B, D. Antécédent de tentative, troubles psychiques, substances, harcèlement, isolement ou contexte familial peuvent s'associer au risque. Ils appellent une attention professionnelle sans prédire individuellement un passage à l'acte. A : Vrai. Il fait partie des facteurs de vulnérabilité cités. B : Vrai. Les situations sont multifactorielles. C : Faux. Une liste de facteurs ne remplace pas l'appréciation de la situation. D : Vrai. L'environnement relationnel compte dans l'évaluation. E : Faux. Tentative et décès sont deux événements distincts.

Q54 — Réponses : A. Une association décrit des tendances dans une population. Les facteurs sont multiples ; elle ne prouve pas qu'une personne donnée sera violente ni que la violence serait inévitable. A : Vrai. Les facteurs familiaux et sociaux sont multiples. B : Faux. Ces éléments sont nécessaires pour interpréter les résultats. C : Faux. Une fréquence ne justifie ni ne rend inévitable une conduite. D : Faux. Les situations sont multifactorielles. E : Faux. Une tendance collective n'est pas une prédiction individuelle.

Âge adulte, ménopause et andropause

Q55 — Réponses : A, B. Non. Maturité et autonomie sont des repères ; couple, parentalité, emploi, séparation ou retraite sont des transitions possibles, avec des trajectoires variées. A : Vrai. Ces repères ne constituent pas un scénario individuel obligatoire. B : Vrai. Les changements se poursuivent au cours de cette période. C : Faux. Les transitions sociales et familiales ne sont pas obligatoirement liées. D : Faux. Aucun événement familial particulier n'est obligatoire. E : Faux. La maturité ne signifie pas l'absence de changement.

Q56 — Réponses : B, C. Elle correspond à l'arrêt de l'activité ovarienne cyclique, de l'ovulation et des menstruations, avec une forte diminution des sécrétions ovariennes. Cela ne signifie pas la disparition de toutes les hormones sexuelles du corps. A : Faux. L'arrêt cyclique ne signifie pas une disparition totale des hormones. B : Vrai. C'est le changement reproductif central décrit. C : Vrai. Sommeil, ressenti thermique ou anxiété ne suivent pas un tableau identique chez toutes. D : Faux. Cinquante ans est un ordre de grandeur moyen, non une date obligatoire. E : Faux. La première menstruation est la ménarche.

Corrigés argumentés

Q57 — Réponses : A, E. L'andropause décrit une baisse progressive et variable de testostérone chez certains hommes. Elle n'impose pas un arrêt brutal de la fertilité ; la production de spermatozoïdes peut persister. A : Vrai. L'arrêt reproductif n'est pas systématique. B : Faux. Les manifestations sont variables. C : Faux. La baisse est progressive et variable, à distinguer de l'arrêt ovarien cyclique. D : Faux. Il s'agit d'un changement hormonal possible avec l'âge. E : Vrai. Le changement ne se produit pas de la même façon chez tous.

Q58 — Réponses : D, E. Non. Elle peut demander des adaptations durables et parfois entraîner un handicap, sans que celui-ci soit automatique. Ses effets peuvent être physiques, psychiques et sociaux. A : Faux. Le handicap est une conséquence possible, non systématique. B : Faux. Elles peuvent survenir à d'autres étapes de vie. C : Faux. Une évolution vers la guérison est possible. D : Vrai. Son effet ne se limite pas au fonctionnement d'un organe. E : Vrai. Sa persistance peut modifier le quotidien.

Vieillissement : définitions et contexte

Q59 — Réponses : A, B, D. La sénescence est le vieillissement naturel des cellules et tissus. La gériatrie est la médecine des personnes âgées ; la gérontologie étudie le vieillissement dans plusieurs dimensions. A : Vrai. Elle ne désigne pas à elle seule une maladie particulière. B : Vrai. Son objet est plus large que les seules pathologies. C : Faux. C'est l'étude multidimensionnelle du vieillissement. D : Vrai. Elle est consacrée aux personnes âgées. E : Faux. Vieillissement et maladie sont distincts.

Q60 — Réponses : B, C. La capacité d'adaptation peut diminuer sans défaillance immédiate au repos. Le vieillissement est hétérogène selon les organes, les personnes, les maladies et l'environnement. A : Faux. Tendance physiologique et pathologie doivent être distinguées. B : Vrai. La réserve concerne notamment la capacité à répondre à une sollicitation. C : Vrai. Le processus est hétérogène. D : Faux. Elle peut d'abord limiter l'adaptation à l'effort ou au stress. E : Faux. Les trajectoires individuelles diffèrent.

Q61 — Réponses : A, E. C'est un indicateur statistique fondé sur les conditions de mortalité d'une période. Une tendance de long terme peut comporter des reculs ponctuels ; elle ne fixe pas la durée de vie d'une personne. A : Vrai. C'est un indicateur de population. B : Faux. Elle ne prédit pas une trajectoire individuelle. C : Faux. Leur date et leur contexte doivent être conservés. D : Faux. Une tendance de long terme n'exclut pas les baisses. E : Vrai. Des événements tels que canicules et épidémies peuvent faire reculer l'indicateur.

Corrigés argumentés

Vieillissement : comprendre les grandes fonctions

Q62 — Réponses : D, E. Renouvellement cutané et élasticité peuvent diminuer, avec sécheresse ; masse et résistance osseuses peuvent baisser ; masse, force et fonction musculaires peuvent se réduire. A : Faux. La trajectoire comporte un maximum puis une diminution possible. B : Faux. L'élasticité cutanée peut diminuer. C : Faux. Elle constitue une vulnérabilité, distincte d'une fracture constituée. D : Vrai. La masse ne résume pas à elle seule la performance. E : Vrai. Les modifications de la peau et des annexes contribuent à ce changement.

Q63 — Réponses : A, D. Une augmentation de masse myocardique n'implique pas un gain de performance et n'est pas obligatoire avec l'âge. Les modifications cardiovasculaires et respiratoires peuvent diminuer les capacités d'adaptation. A : Vrai. Taille et performance sont deux dimensions différentes. B : Faux. Ce mécanisme universel ne peut pas être retenu. C : Faux. Les capacités d'adaptation peuvent diminuer. D : Vrai. Elle correspond aux échanges gazeux pulmonaires. E : Faux. Elle relève des échanges gazeux, non de l'endocrinologie ovarienne.

Q64 — Réponses : A, B. La filtration rénale peut diminuer ; sensation de besoin, vessie et contrôle sphinctérien peuvent changer. Une incontinence n'est pas une conséquence inévitable à banaliser. A : Vrai. Ces fonctions sont distinctes de la filtration. B : Vrai. Elle relève du fonctionnement du rein. C : Faux. Elle est possible, sans être universelle ni à banaliser. D : Faux. Produire l'urine et contrôler son émission sont distincts. E : Faux. Son volume peut avoir un retentissement urinaire.

Q65 — Réponses : B, C, D. Des difficultés dentaires ou une baisse du goût peuvent gêner l'alimentation. Un ralentissement du transit peut favoriser la constipation ; les défenses immunitaires peuvent aussi devenir moins efficaces. A : Faux. Elle peut influencer l'appétit. B : Vrai. Les fonctions digestives et sensorielles interagissent. C : Vrai. C'est une évolution possible, non une obligation individuelle. D : Vrai. Les réponses des lymphocytes T et B peuvent être modifiées. E : Faux. Transit et immunité sont des fonctions distinctes.

Q66 — Réponses : B, C. La presbytie gêne surtout la mise au point de près par modification de l'accommodation. Audition, goût, toucher et rythmes du sommeil peuvent aussi évoluer, avec des effets sur le quotidien. A : Faux. Elle concerne la vision, non ce réflexe. B : Vrai. Elle est liée aux modifications de l'accommodation. C : Vrai. Certaines informations orales peuvent être moins bien perçues. D : Faux. Les évolutions sont variables et hétérogènes. E : Faux. Ils peuvent se modifier avec l'âge.

Corrigés argumentés

La mort et la fin du parcours physiologique

Q67 — Réponses : D. La mort est la cessation complète et définitive de la vie. Le caractère irréversible est essentiel ; l'arrêt isolé d'une fonction ne prouve pas dans toute situation son irréversibilité. A : Faux. Arrêt fonctionnel et irréversibilité ne se confondent pas dans toute situation. B : Faux. Sénescence et mort de l'organisme sont des notions distinctes. C : Faux. L'Apgar apprécie l'adaptation néonatale et ne définit pas juridiquement le décès. D : Vrai. Les caractères complet et définitif sont essentiels. E : Faux. Une baisse de réserve n'est pas une cessation définitive de la vie.

Q68 — Réponses : B, E. Les fonctions nerveuses, respiratoires et circulatoires sont interdépendantes. Une défaillance peut retentir sur les autres ; leur appréciation clinique ne se réduit pas à un signe isolé. A : Faux. La perfusion et les échanges soutiennent les organes. B : Vrai. Ces fonctions sont interdépendantes. C : Faux. Ce changement possible du vieillissement ne constitue pas cette définition. D : Faux. Les procédures de constat du décès ne peuvent pas se déduire de cette simplification. E : Vrai. Le maintien d'une fonction dépend notamment des autres.